

• 论著 •

中医定向透药治疗感染后咳嗽临床效果分析

鲍玉芳, 金琦, 凌玲, 丁嘉怡

(上海市浦东新区中医医院, 上海)

摘要: **目的** 探讨中医定向透药治疗感染后咳嗽临床疗效及安全性。**方法** 选择在我院治疗的 118 例感染后咳嗽患者, 随机分为外用定向透药组 (治疗一组 39 例), 宣肺止咳方组 (治疗二组 39 例), 复方甲氧那明组 (对照组 40 例)。对比三组的治疗有效率、日间、夜间咳嗽评分。**结果** (1) 三组患者临床疗效对比: 一组的总有效率显著高于治疗二组、对照组 ($P<0.05$); (2) 三组患者日间、夜间咳嗽评分对比: 一组的日间、夜间咳嗽评分显著低于二组、对照组; 三组评分对比, $P<0.05$ 。**结论** 中医定向透药方法为治疗感染后咳嗽的有效方法, 值得推广。

关键词: 感染后咳嗽; 中医定向透药; 疗效

中图分类号: R256.11

文献标识码: A

DOI: 10.19613/j.cnki.1671-3141.2019.76.009

本文引用格式: 鲍玉芳, 金琦, 凌玲, 等. 中医定向透药治疗感染后咳嗽临床效果分析 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2019, 19(76): 18-19.

Analysis of Clinical Effect of Directional Penetration of Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Post-Infectious Cough

BAO Yu-fang, JIN Qi, LING Ling, DING Jia-yi

(Shanghai Pudong New District Hospital of Traditional Chinese Medicine, Shanghai)

ABSTRACT: Objective To explore the clinical effect and safety of traditional Chinese medicine directed drug in the treatment of post-infection cough. **Methods** 118 patients with post-infection cough who were treated in our hospital were randomly divided into the traditional Chinese medicine directed drug group (treatment group one with 39 patients), the Xuanfeizhike decoction group (treatment group two with 39 patients) and the compound methoxyphenamine group (control group with 40 patients). The three groups were compared for treatment effectiveness, daytime and nighttime cough scores. **Results** The effective rate of the treatment group one was significantly higher than the treatment group two and the control group ($P<0.05$); The daytime and nighttime cough scores of the treatment group one were significantly lower than the treatment group two and the control group ($P<0.05$). **Conclusion** Traditional Chinese medicine directed drug therapy is an effective method for post-infection cough and worth promoting.

KEY WORDS: Cough after infection; Directional penetration of traditional Chinese medicine; Curative effect

0 引言

感染后咳嗽是指当呼吸道感染急性期症状消失后, 咳嗽仍然迁延不愈, 主要表现为刺激性的干咳或者咳少量白色黏液痰, 一般持续 3~8 周。该病经过上呼吸道感染治疗后, 虽然恶寒发热、头身疼痛、鼻塞流涕等外感症状, 随病程的减退而消失, 但常常会在一段时间里存在刺激性的干咳、咽痒、无痰或少量白粘痰等临床表现^[1]。其体征可有咽喉壁充血, 其 X 线胸片及血常规检查无异常。感染后咳嗽虽有自限性, 但过程中可能会严重影响患者的工作和生活, 且一部分科发展为慢性咳嗽。西医常规吸氧、抗感染以及止咳等系列方法的应用, 无法获得明显效果^[2,3]。对此临床有必要探索更为有效方法对感染后咳嗽患者进行治疗, 近年来我们采用中医定向透药治疗方法, 对于咳嗽等病症的改善, 有较好的疗效, 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院 2017 年 12 月至 2019 年 5 月本院收治的 118 例感染后咳嗽患者, 随机分为治疗一组、治疗二组、对照组, 治疗一组 39 例患者中有 19 例男、20 例女; 年龄为 18~68 岁, 平均 (46.62 ± 5.12) 岁; 病程为 22~55 d, 平均 (39.23 ± 5.43) d。治疗二组 39 例患者中有 18 例男、21 例女; 年龄为 18~69 岁, 平均 (46.63 ± 5.42) 岁; 病程为 21~60 d, 平均 (39.27 ± 5.53) d。对照组 40 例患者中有 21 例男、19 例女; 年龄为 18~70 岁, 平均 (46.65 ± 5.53) 岁; 病程为 21~62 d, 平均 (39.38 ± 5.61) d。3 组患者的基础资料比较 ($P>0.05$), 有可比性。

纳入标准: (1) 确诊为感染后咳嗽: 感染后咳嗽诊断标准, 参考中华医学会呼吸病学分会哮喘学组制定的《咳嗽的诊断与治疗指南 (2015)》制定。症状: 当呼吸道感染的急性期症状消失后, 咳嗽仍然迁延不愈, 多表现为刺激性干咳或者咳少量白色黏液痰, 通常持续 3~8 周。体征: 可有咽部充血, 双肺呼吸音正常或者增粗等体征。 (2) 符合中医症候标准: 参照《中华人民共和国国家标准: 中医临床诊疗术语症候部分》、《中医诊断学》、《中医内科学》

以及结合本病特点而制定。辨证属“风寒束肺”证。症见: 咳嗽, 咳声重浊, 痰质稀薄, 痰色白, 饮食生冷或受凉咳甚, 咽痒, 喜热饮, 鼻塞, 流白稀涕, 畏寒背冷, 头身重, 小便清长, 大便稀溏, 口淡, 舌淡, 苔薄白, 脉浮紧。 (3) 年龄在 18 岁至 70 岁之间, 性别不限; (4) 能坚持治疗, 知情同意并配合调查者; (5) 治疗前一周内未采用过中药内服、外用。

排除标准: (1) 不符合上述西医诊断和中医症候诊断标准者; (2) 既往病史或检查证实由咳嗽变异性哮喘 (CVA)、嗜酸粒细胞性支气管炎 (EB)、上气道咳嗽综合征 (UACS)、肺炎所致的咳嗽; (3) 有皮肤病疾病患者; (4) 妊娠或哺乳期妇女、对本药过敏者; (5) 合并有心动过速、心律失常、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病、精神病患者; (6) 含有影响疗效观察因素者; (7) 凡不符合纳入标准, 未按规定用药, 无法判定疗效或资料不全等影响疗效或安全性判断者。

1.2 方法

治疗一组: 外用定向透药组: 炒芥子 20 g, 肉桂 5 g, 制吴茱萸 6 g, 细辛 15 g, 醋延胡索 20 g, 制甘遂 15 g。将上述药物打粉混合, 操作时加入适量生姜汁将制备的药粉定型为 $2\text{cm} \times 2\text{cm} \times 1\text{cm}$ 圆柱状药饼。选择“大椎、肺腧、天突”定向透药, 将药饼置上述穴位后将电极板压在药饼之上, 沙袋按压固定, 调节电流至 15 级左右, 透药时间为 25 min。隔日 1 次, 每周做 3 次。共二周。

治疗二组予宣肺止咳方: 炙麻黄 9 克、苦杏仁 12 克、生甘草 6 克、紫苑 12 克、百部 9 克、荆芥 10 克、桔梗 9 克、枳壳 9 克、橘皮 9 克、白前 12 克、前胡 12 克、射干 6 克、蝉蜕 6 克组成。每日一剂, 分 2 次煎服各 200 mL。7 天一个疗程, 共二个疗程。

对照组: 予以复方甲氧那明胶囊 [厂家: 上海信谊药厂有限公司, 批号: 国药准字 H10980260, 规格: 45 s] 进行治疗, 口服 2 粒/次, 3 次/d, 持续服用 14 d。

1.3 观察指标

比较 3 组患者的临床疗效、中医症候疗效, 咳嗽积分变化情况, 咳嗽分级采用中华医学会呼吸病学分会哮喘学组制定的《咳嗽的诊断与治疗指南 (2015)》里咳嗽积分表, 从咳嗽强度、频率以及影响生活质量三方面对咳嗽严重程度进行评价。0 分: 患者未表现出日间咳嗽以及夜间咳嗽; 1 分: 患者表现出日间以及夜间偶尔咳嗽, 表现出时间短暂的特点; 2 分: 患者表现出日间以及夜间频繁咳嗽, 对正常生活以及睡眠造成影响; 3 分: 患者表现出日间以及夜间频繁咳嗽, 正常生活以及睡眠受到正常影响。

基金项目: 1. 上海市卫健委-中医优势病种培育项目, 编号: zybzb-2017048; 2. 上海市浦东新区卫健委-特色专病, 编号: PWZzb-2070-30。

作者简介: 鲍玉芳 (1967-), 女, 副主任医师, 研究方向: 主要从事中医肺病临床与研究。

1.4 统计学方法

采用统计学软件 SPSS 20.0 进行统计分析,计数资料(治愈率、治疗总有效率)、计量资料(咳嗽积分)分别以率(%), $(\bar{x} \pm s)$ 表示,分别行 χ^2 检验、 t 检验, $P < 0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较

一组的总有效率(94.87%)显著高于二组(84.62%)、三组(72.50%),各组在性别、病程方面差异无统计学意义($P > 0.05$);各组间比较差异均有统计学意义($P < 0.05$)。见表 1。

表 1 临床疗效对比 (n (%))

组别	n	痊愈	显效	有效	无效	总有效
治疗组一	39	17 (43.59)	8 (20.51)	12 (30.77)	2 (5.13)	37 (94.87) Δ
治疗组二	39	12 (30.77)	13 (33.33)	8 (20.51)	6 (15.38)	33 (84.62)
对照组	40	8 (20.00)	11 (27.50)	10 (25.00)	11 (27.50)	29 (72.50)

注:与治疗组二、对照组比较, $\Delta P < 0.05$ 。

2.2 两组患者日间、夜间咳嗽计分对比

经统计学分析,治疗后治疗一组的日间咳嗽计分(0.80 ± 0.46)分显著低于治疗二组(1.19 ± 0.76)分、对照组(1.32 ± 0.93)分;其夜间咳嗽计分(0.77 ± 0.38)分显著低于治疗二组(1.18 ± 0.82)分、对照组(1.25 ± 0.86)分;其差异均有统计学意义($P < 0.05$)。见表 2。

表 2 日间、夜间咳嗽计分对比 ($\bar{x} \pm s$)

组别	日间咳嗽计分(分)	夜间咳嗽计分(分)
治疗一组	0.80 ± 0.46 Δ	0.77 ± 0.38 Δ
治疗二组	1.19 ± 0.76	1.18 ± 0.82
对照组	1.32 ± 0.93	1.25 ± 0.86

注:分别与治疗二组、对照组的日间咳嗽计分、夜间咳嗽计分比较, $\Delta P < 0.05$ 。

3 讨论

近年来随着临床研究的深入,感染后咳嗽渐渐被作为一个疾病来看待,因其病因难以确定,且发病机制尚不明确^[4-5],所以经常被误诊为感冒、气管炎、咽炎等,且存在较多不合理应用抗生素的问题,给患者的工作、生活造成影响的同时,也加重了社会医疗成本支出的增加。从现代医学角度来看,感冒后咳嗽为病毒感染后引起呼吸道的变态反应性炎症,其引发因素与气道高反应性和继发免疫缺陷存在相关性,它不仅对气道上皮造成损伤,还会使其屏障功能损失,且炎性递质释放的同时会引发神经-受体机制功能的异常^[6]。从临床疗效上看,主要采用对症治疗,如止咳、镇咳、抗感染、解痉、抗过敏、激素等,疗效不理想,停药易复发,部分病人大量使用抗菌药物治疗无效。中医对此类咳嗽有较大优势。

感染后咳嗽属于中医学“咳嗽”“久咳”等范畴,《素问·咳论》记载“其寒饮食入胃,从肺脉上至于肺则肺寒,肺寒则外内合邪,因而客之,则为肺咳”,强调寒邪易侵袭肺脏,形成肺咳^[7]。祖国学认为,风寒束肺型是本病常见证型,一般是由于感冒初期未得到及时有效的治疗,而造成风寒之邪不能彻底疏散,伏留于肺,致使肺气壅塞,肺失清肃,迫气上逆,引发咳嗽,因此在临床治疗中应以散寒祛风、温肺止咳为主^[8]。

中医认为人体皮肤腠理与五脏六腑相通,药物可以通过体表到达脏腑,起到调整机体、抗病祛邪的作用。近年来,经皮给药技术是许多疾病治疗的研究热点,是 WHO 提倡的第 3 种给药途径^[9]。肺腧穴是足太阳膀胱经之腧穴,是肺卫经气输注所在。大椎穴为督脉的强身要穴,为诸阳之会。《类经图翼》载“大椎,主治五劳七伤,乏力,风劳食气,咳症久不愈。”天突穴为任脉要穴,内应肺系,外通气窍,为气息出入的要塞。天突、大椎、肺腧穴相配,外用芥子、肉桂、细辛、吴茱萸等温补辛散中药组成外用方通过定向透药将药贴中浓缩的中药成分经过皮肤渗透到毛细血管再经体液循环到达病灶部位,从而产生药效,起到宣肺平喘、降气祛痰、温经散寒之功。有报道指出中药定向透药仪更具有穴位治疗和热敷治疗的多重功能^[10]。

从本研究结果显示,利用现代仪器进行定向透药治疗,其疗效要优于口服中药组和西药组,这可能与患者的依从性有关,它避免服药、注射等治疗方式的痛苦及副作用,患者的接受度较高,值得推广。

参考文献

- [1] 潘玲玲,石志敏.从胃肺论治针刺治疗感染后咳嗽[J].长春中医药大学学报,2014,30(5):892-894.
- [2] 张丽霞,李雪青,石志敏.麻黄附子细辛汤联合孟鲁司特治疗咳嗽变异性哮喘的临床观察[J].中医药信息,2017,34(4):80-83.
- [3] 俞秋云,陈燕,唐斌,等.朱佳运用加味玉屏风散治疗感染后咳嗽经验[J].湖南中医杂志,2018,34(10):21-23.
- [4] Ishida T, Yokoyama T, Iwasaku M, et al. Clinical investigation of post-infectious cough among adult patients with prolonged cough[J]. Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi, 2010, 48(3):179-185.
- [5] Braman SS. Postinfectious cough: ACCP evidence-based clinical practice guidelines[J]. Chest, 2006, 129(S1):138-146.
- [6] 廖定华.罗浮山百草油吸入法联合加味止咳散治疗感冒后咳嗽疗效观察[J].中国药业,2017,26(18):58-60.
- [7] 史利卿,林彬,马建岭,等.感染后咳嗽的中医证因特点初探[J].中华中医药杂志,2016,31(2):595-597.
- [8] 胡倩,王秋琴,段培蓓,等.刮痧联合宣肺止咳汤治疗感染后咳嗽风寒恋肺证临床观察[J].中国针灸,2016,36(12):1257-1262.
- [9] 王胜,叶海勇,陈悦,等.302例慢性阻塞性肺疾病急性加重期中医证候分型[J].北京中医药大学学报,2015,38(1):57-62.
- [10] 李萍.中医定向透药疗法配合针刺对腰椎间盘突出症的疗效及护理[J].世界最新医学信息文摘,2016,16(72):297.